복부초음파에서 자주 나오는 소견

검진이나 진료 중 복부초음파에서 간·콩팥의 물혹, 담석, 담낭용종이 종종 발견됩니다. 대부분 크게 걱정할 소견은 아니지만, 언제는 지켜보고 언제는 추가로 확인하는지 정리했습니다.

간 물혹과 콩팥 물혹



간·콩팥의 물혹과 담낭 안 담석

소견	대부분은	더 확인하는 경우
간 물혹	간의 단순 물혹은 흔히 발견되며, **임상적으로 의미가 크지 않아** 증상이 없으면 치료 없이 지켜봅니다.	벽이 두껍거나 모양이 애매하면 추가 영상검사를 상담합니다.
콩팥 물혹	단순 물혹은 **위험도가 높지 않습니다.**	물혹 안에 **칸막이**가 있거나 **벽이 두껍거나**, 조영제를 넣고 찍었을 때 **진하게 보이는 부분**이 있으면 CT·MRI로 위험도를 나눕니다 (보즈니악 분류).

담석 · 담낭용종

소견	증상이 없을 때	이럴 때는
담석	증상이 없는 **담낭 담석**은 대부분 바로 수술하지 않고 관찰합니다. 담석이 **3cm 이상이면** 증상이 없어도 수술의 이득과 위험을 상담할 수 있습니다.	기름진 식사 뒤 **오른쪽 갈비뼈 아래나 명치**가 쥐어짜듯 아프면 외과 진료를 상담하세요. 통증이 계속되면 예정된 진료를 기다리지 말고 빨리 진료받으세요. **열이나 황달이 함께 생기면 응급실로 가세요.**
담낭용종	**크기·모양에 따라 관찰하거나 수술을 상담합니다.** 추적 중 저절로 없어지기도 합니다.	크기별 기준은 **'담낭 폴립 추적 안내'**를 참고하세요.

연자 Q&A: 과거 산통이 있었다면 1년 내 재발 20~50%, 급성담낭염으로 진행 1~2%를 설명했습니다. 현재 통증이 없어도 과거 병력이 중요합니다. (아산28 · 무증상 담낭질환, 언제 수술할 것인가?(이우형))

오동욱 연자는 담관·췌관 확장의 원인을 영상으로 평가하며, 원인이 설명되지 않는 명확한 주췌관 확장은 MRCP 또는 EUS로 평가하고, 새로 생기거나 진행하는 확장·급격한 단절·하류 위축·담관 동반 확장은 적극 평가한다고 답했습니다.

(아산28 · 만성췌장염: 진단의 핵심과 치료의 실제(오동욱))

오동욱 강의: 새로운 당뇨·혈당 악화, 체중 감소·황달, 국소 췌관 협착과 상류 확장은 췌장암 감별의 단서입니다. CA19-9 하나로 선별하지 않습니다. (아산28 · 만성췌장염: 진단의 핵심과 치료의 실제(오동욱))

초음파의 한계와 흔한 오해

흔한 오해 · 알아 두기	바로 알기
"담석이 있으면 무조건 수술해야 한다"	증상이 없으면 대부분 관찰합니다.
"초음파로 복통 원인을 다 알 수 있다"	복부초음파는 장 속 공기에 가려 **췌장은 일부만** 보일 수 있어, 필요하면 다른 검사를 함께 봅니다.
알아 두기 — 검사 전 금식	검사 전 **금식**하면 담낭이 잘 펴져 더 정확하게 보입니다.

응급실로	빨리 진료가 필요한 경우
오른쪽 윗배 통증이 계속되면서 **열이나 황달**이 함께 생길 때	콩팥 물혹이 있는 분에서 **혈뇨, 발열, 새로 생긴 옆구리 통증**이 있을 때

담낭 폴립 추적 안내 edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/gallbladder-polyp-followup/
검사 전 준비 안내 edu.gwanggyobarun.com/handouts/imaging/abdominal-ultrasound-prep/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한간담췌외과학회 단순 간낭종 진료지침 2025 · 캐나다비뇨의학회 낭성 신장 병변 지침 2023 · NICE 담석질환 지침(CG188) 2014 · 일본 담석질환 진료지침 2021 · 대한복부영상의학회 담낭용종 권고 2025(KJR)

본 자료는 일반 안내입니다. 실제 크기·모양·추적 간격은 검사 소견과 위험요인에 따라 담당 의료진과 상담해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/imaging/abdominal-us-common-findings/